



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نشوه محمد عبدالله السيد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : البساتين
رقم البطاقة : 28208040101123 رقم التليفون : 01110330420
العنوان : التهامي
العمر (تاريخ الميلاد) : 04-08-1982 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نشوه محمد عبدالله السيد National ID: 28208040101123	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٤/١
٢٨٢٠٨٠٤٠١٠١٢٣
حاصلة على بكالوريوس تجارة
مستلمة
إتش
محمّد عبدالله قنينة عبدالله
الطالبة مازونة هاشم
٢٠٢١/١٠/١٤



KU7530467



٢٨٢٠٨٠٤٠١٠١٢٣

نشورة
محمّد عبدالله السيد احمد
إش سلامة حبيبة قاوية كامل
البياتين - القاهرة

جامعة فلسطين التقنية
الغزة - فلسطين



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : تشو محمد عبدالله السيد أحمد

Sex:

3- Medical number:

Female

83238052

Old Med :

Old Med :

3581-2024

2-ID number:

Patient Age : 42 Y



Family history

Family history

-ve

Phone

Phone

0110330420

BMI

BMI

REASON OF MDT

AE

marital status

Marital Status

MARRIED

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date

Co morbidity

Co-Morbidity

-ve

Menopausal
status

Menopausal Status

PREMENOPAUSE

Initial STAGE

Initial STAGE

02

Clinical data

Breast Imaging :

RUOQ AT 2 O'CLOCK 2.6X1.7 CM WITH DISMOPLASTIC

Mets Workup :

few small bilateral pulmonary nodules

BX IDC	ER 0/8	PR 4/8	Her 2 Neu 0	SISH	KI67 35
74 COMMENT ii	ER COMMENT	PR COMMENT	Her 2 Neu COMMENT	SISH COMMENT	

T CT2	N 0	M 0
----------	--------	--------

Sonomammography

PATIENT HISTORY

ECHO, LABS

BONE SCAN

CLIP INSERTION

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

NACT ACX4 TAXOL CARBOX12 FOLLOWED BY LT BCS AND SLNB

ZOLADEX FOR OVARIAN FUNCTION

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ الاء جميل	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ رانيا علي
SURGERY	SURGERY د/ المقصود محمد	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

Name: نشوى محمد عبدالله		
MR. : 367		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحيه طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته تاريخ وساعة الدخول : تاريخ وساعة الخروج :		
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient discontinued her port on 25/11/2025 and reported ongoing skin ulceration; tamoxifen therapy was continued. The patient presented on 31/01/2026 for tamoxifen 20 mg and supportive treatment planned for three months. The most recent estrogen level on 02/11/2025 was 18; a follow-up estrogen level is scheduled for March 2026. A CT of the chest performed on 08/09/2025 demonstrated a left axillary lymph node measuring approximately 9 mm. A comparative CT of the chest, abdomen, and pelvis was obtained. On 04/07/2026 the patient was seen for tamoxifen and continued supportive treatment for three months. An annual assessment of bone mineral density (BSM) and a pelvic ultrasound (PAUS) were performed in May 2026. The patient was advised to return to clinic after three months. On 03/09/2026 the patient, known to have non-metastatic breast cancer, complained of bony pain. The plan was to increase paracetamol to 1000 mg every 8 hours.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 18-09-2026
Reham Ahmed Fathy Ibrahim		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذة / نشوة محمد عبدالله السيد احمد	Request No. : 13005086
Patient No. : 28208040101123	Request Date : 01/10/2024
Path No. : 3719/24	Verification Date : 16/10/2024
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Age : 42 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast swelling.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 30/9/2024.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Angioinvasion: No.
- * Lymphocytic infiltrate.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: No nuclear reaction in the tumor cells (score 0 /8).
 - PR: Faint nuclear reaction in 10% of tumor cells (score 4 /8).
 - Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
 - Ki67: 60% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast swelling, Tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II.

IPT:

- P63: Negative.
- ER: Negative (score 0 /8).
- PR: Positive (score 4 /8).
- Her2: Negative (score 0).

Verified by :

DR.Menna Nabil



Patient Name: Nashwah Mohamed Abd Allah Al Sayed Ahmed	Date : 25/09/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 28208040101123	Pat. ID: 79181

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

left breast palpable lump.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast shows UOQ micro lobulated irregular mass lesion, of high density.
- Complementary ultrasound revealed left breast irregular micro lobulated heterogenous hypoechoic mass lesion, with vascularity detected within on color Doppler, seen at 2 o'clock position 111mm from the nipple, 7mm from the overlying skin, measuring 26x17mm surrounding by desmoplastic reaction,
- No right solid or cystic mass lesion.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex.
- Bilateral Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Left breast UOQ malignant looking mass lesion (BIRADS 4c) for histopathological correlation.
- Benign findings right breast (BIRADS 2).

Signature Dr. Nehal Hamd

25/09/2024 3:10



Patient Name: Nashwah Mohamed Abd Allah Al Sayed Ahmed	Date : 19/10/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 3581/2024	Pat. ID: 79181

**NON- CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

1. Chest:

- Left breast LOQ small hypodense soft tissue lesion measures about 2.5x 2.1 cm associated with few small left axillary lymph nodes (levels 1 and 2), the largest measures about 1 cm in short axis.
- Few small bilateral pulmonary nodules (middle lobe and lingula), measures about 4-5 mm.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with homogenous CT texture. No focal lesions (on non- contrast basis) or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal non contrast appearance of the pancreas and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.
- No lytic or sclerotic bone lesions.

OPINION:

A reported case of left breast cancer showing:

- ***Few small bilateral pulmonary nodules, for follow-up.***
- ***No definite abdominal metastatic deposits on non-contrast basis.***

Dr. Ghada H. Khalifa, MSc

Signature Prof. Menna Tallah Hanafy

26/10/2024 03:11 م



Exam Information:

<u>Patient Name:</u> Nashwa Mohamed	<u>Date of birth:</u> 04/08/1982
<u>Arabic Name:</u> نشوى محمد	<u>Patient Gender:</u> F
<u>Patient RIS ID:</u> 365842	<u>Exam Date:</u> 12/02/2025
<u>Patient HIS ID:</u> 10110225002813	
<u>Written by:</u> Dr. Huda Fathy	<u>Approved by:</u> Dr. Huda Fathy

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (12/02/2025)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP
Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder joints and knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Yasmeen El Araby

Mohamed Abdeltawab, MSc